# Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla priorytetów krajowych

| | |
|---|---|
| **Nazwa wskaźnika** | **'3.4.a Wydatki bieżące publiczne na ochronę zdrowia, jako % PKB '** |
| **Cel Zrównoważonego Rozwoju** | Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia |
| **Priorytet** | Poprawa poziomu jakości systemu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta, w tym rozwój obszaru e-zdrowie |
| **Definicja wskaźnika** | Udział wydatków bieżących publicznych na ochronę zdrowia w PKB. |
| **Jednostka prezentacji** | procent [%] |
| **Dostępne wymiary** | ogółem, rodzaj wydatków (wg podejścia funkcjonalnego) |
| **Wyjaśnienia metodologiczne** | Dane pochodzą z badania pn. **Narodowy Rachunek Zdrowia (NRZ)**, którego celem jest zestawienie wydatków na ochronę zdrowia (publicznych i prywatnych) według Międzynarodowej Klasyfikacji Rachunków Zdrowia (International Classification for Health Accounts - ICHA).<br><br>Zakresem podmiotowym badania NRZ są schematy wydatków publicznych/obowiązkowych i prywatnych/nieobowiązkowych na ochronę zdrowia, zaś przedmiotowym - wydatki bieżące na ochronę zdrowia) zestawione zgodnie z ICHA (HP - dostawców, HF - schematów finansowania i HC - klasyfikacji funkcjonalnej świadczonych usług zdrowotnych) i we wzajemnych powiązaniach: HCxHF, HPxHF, HCxHP.<br><br>Kwota wydatków uwzględnianych w NRZ, zgodnie z obowiązującą metodologią, obejmuje wydatki bieżące, a więc nie uwzględnia wydatków kapitałowych, do których zalicza się np. wydatki inwestycyjne, na badania i rozwój, kształcenie.<br><br>Źródłem informacji do NRZ w zakresie wydatków publicznych (HF.1), na które składają się schematy rządowe, schematy obowiązkowych - składkowych ubezpieczeń, są m.in. systemy administracyjne instytucji, które gromadzą dane o wydatkach na ochronę zdrowia (tj. Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Wykorzystywane są również wyniki innych badań realizowanych w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej i inne dostępne źródła informacji, służące głównie do oszacowania wydatków prywatnych.<br><br>Na podstawie klasyfikacji funkcji ochrony zdrowia (ICHA-HC) wyróżniono dwa rodzaje wydatków: wydatki na usługi indywidualne i wydatki na usługi zbiorowe.<br><br>Jako **usługi indywidualne** zaklasyfikowano produkty i usługi medyczne wykorzystywane bezpośrednio przez osoby indywidualne w zależności od ich potrzeb, należące według podejścia funkcjonalnego do kategorii: usługi lecznicze (HC.1), usługi rehabilitacyjne (HC.2), długoterminowa opieka zdrowotna (HC.3), pomocnicze usługi opieki zdrowotnej (nie określone przez funkcje) (HC.4) i artykuły medyczne (HC.5).<br><br>Jako **usługi zbiorowe** zaklasyfikowano usługi odnoszące się do wszystkich grup populacji, należące według podejścia funkcjonalnego do kategorii: profilaktyka i zdrowie publiczne (HC.6) i zarządzenie i administracja finansowania ochrony zdrowia (HC.7). |
| **Źródło danych** | Główny Urząd Statystyczny |
| **Częstotliwość i dostępność danych** | Dane roczne; od 2013 r. |

## Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla priorytetów krajowych

| | |
|---|---|
| **Uwagi** | Ze względu na specyfikę metodologii SHA2011 (A System of Health Accounts 2011) dane są przekazywane z dwuletnim opóźnieniem. |
| **Data aktualizacji danych** | 10-03-2026 |
| **Data aktualizacji metadanych** | 26-04-2023 |